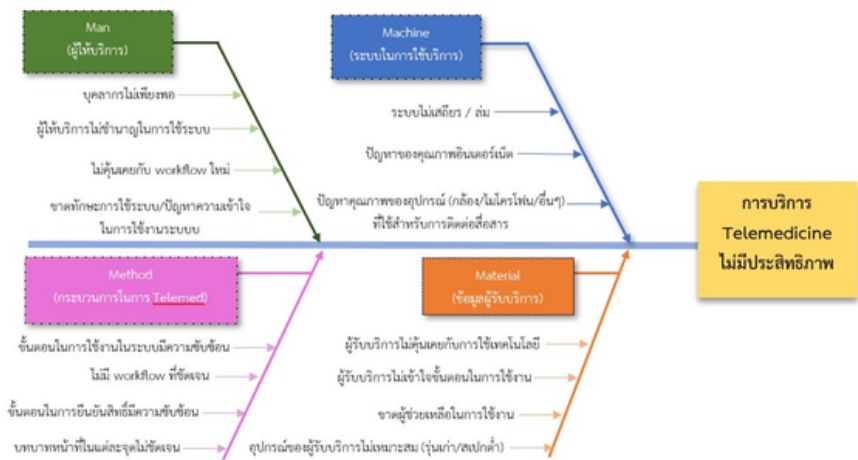


การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Telemedicine ในรพ.เด็ก เพื่อเข้าถึงการให้บริการ

สมาชิกทีม : พว.ปนัดดา มาที, นางสาวจิรัชญา คำทางชล, นางสาวรมณียา พรหมเพ็ญ, นางสาวปวีณา ปิ่นไย

ปัญหาและสาเหตุ

ผู้ป่วยเด็กโรคซับซ้อน/เรื้อรังจากต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการได้ยาก มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี และความเข้าใจในการใช้ระบบ ทำให้เข้าสู่ระบบไม่ได้ เกิดการเลื่อนนัด หรือขาดความต่อเนื่องในการติดตามอาการ



วัตถุประสงค์

- 1 บริการ Telemedicine มีมาตรฐาน สะดวก และมีประสิทธิภาพ
- 2 เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดเวลาเดินทาง ค่าใช้จ่าย และระยะเวลารอคอย
- 3 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อาการคงที่ที่ได้รับการติดตามรักษา และรับยาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษา
- 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และขยายการให้บริการครอบคลุมคลินิกเฉพาะทางมากขึ้น

แนวคิด SMART Telemedicine Model

- S** Standardized Service: พัฒนาระบบการให้บริการมาตรฐานเดียวกันทุกคลินิก
- M** Multidisciplinary Coordination: บูรณาการการทำงานของทีมสหวิชาชีพ
- A** Accessible Digital Healthcare: เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
- R** Reminder & Readiness System: ระบบแจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมก่อนรับบริการ
- T** Technology-enabled Integrated Care: บูรณาการเทคโนโลยีและกระบวนการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพบริการและสนับสนุนการพัฒนา Smart Hospital

กระบวนการพัฒนาแบบ PDCA (หลายรอบ) อย่างต่อเนื่อง

PLAN

- รอบที่ 1
- Workflow ขั้นตอนมีความสับสนและไม่มีขอบเขตของงานชัดเจน
 - ออกแบบแนวทางปฏิบัติการรับบริการใหม่
 - ประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้รับบริการ
 - คู่มือ QSNICH APP เดิมมีหลายใบ ทำให้ผู้ปกครองสับสนอ่านไม่ครบถ้วน

DO

- จัดทำ Workflow ใหม่ แบ่งเป็น
 - วันก่อนรับบริการ
 - วัน Telemedicine
- แจ้งหน่วยต่างๆ ทดลอง workflow ใหม่
- ทำคู่มือลงทะเบียน QSNICH APP แบบ One page
- ทดลองใช้กับผู้ป่วย

CHECK

- เจ้าหน้าที่ตามหน่วยต่างๆ สามารถปฏิบัติงานตาม Flow ได้สำเร็จ
- ผู้รับบริการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองมากขึ้น

ACT

- ปรับ workflow และคู่มืออย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในระบบ

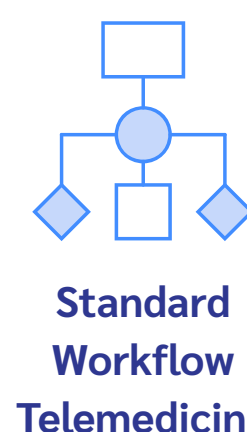
ผลลัพธ์รอบที่ 1

ภาพขั้นตอนการรับบริการรักษาทางไกล version 1

ภาพขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP version 1



นวัตกรรมและเครื่องมือที่พัฒนา



ผลลัพธ์ วงล้อรอบที่ 2

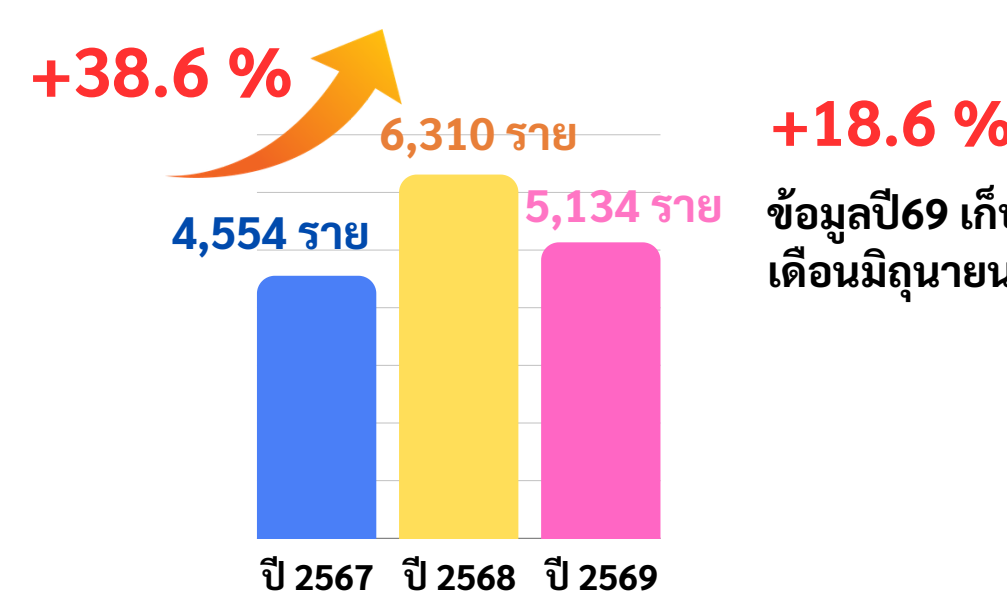
ภาพขั้นตอนการรับบริการรักษาทางไกล version 2

ภาพขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP version 2



ผลลัพธ์ (Outcome)

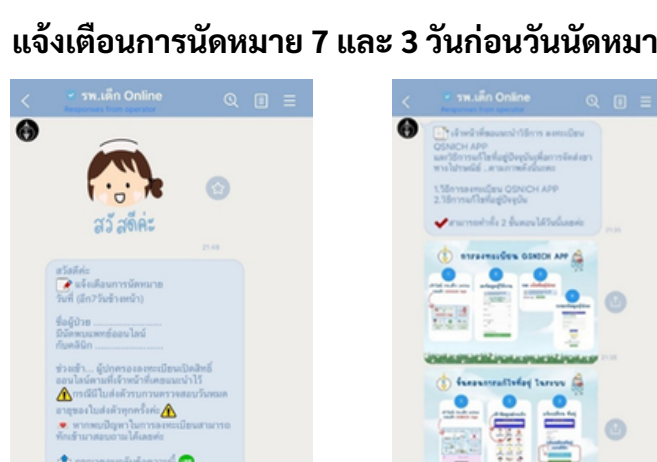
จำนวนผู้รับบริการ Telemedicine



ผลลัพธ์ วงล้อรอบที่ 3

ภาพขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP version 3

Pre-call Reminder
แจ้งเตือนการนัดหมาย 7 และ 3 วันก่อนนัดหมาย

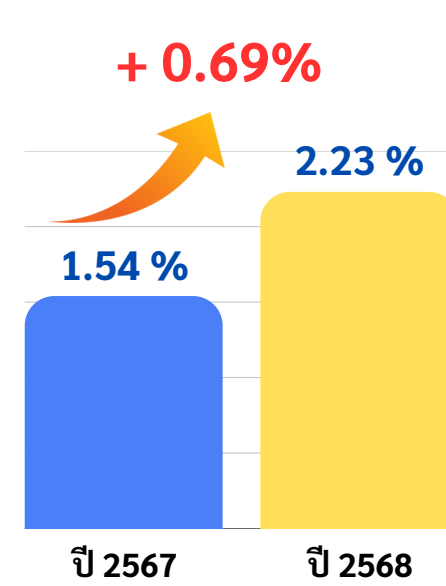


ภาพขั้นตอนการเปิดสิทธิการรักษาในสิทธิต่างๆ

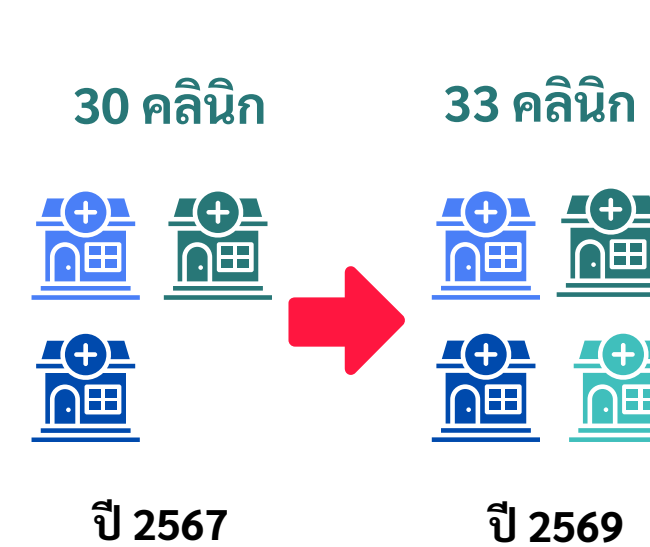


ผลผลิต (Output)

สัดส่วน Telemedicine ต่อผู้รับบริการ OPD



จำนวนคลินิกที่ให้บริการ

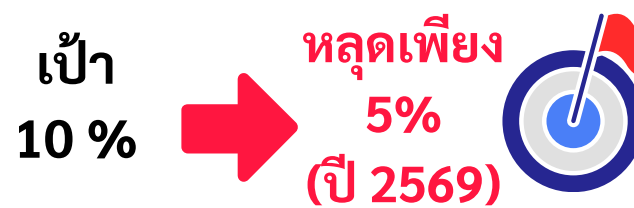


ความพึงพอใจผู้รับบริการ 90%



ความพึงพอใจผู้ให้บริการ 90%

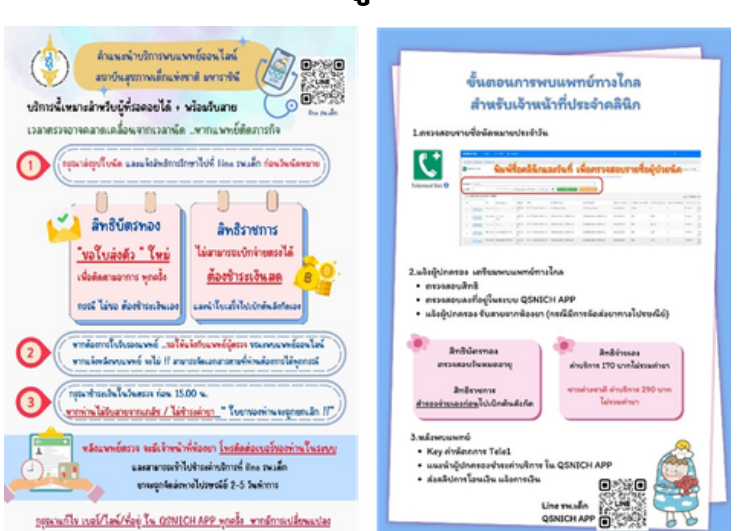
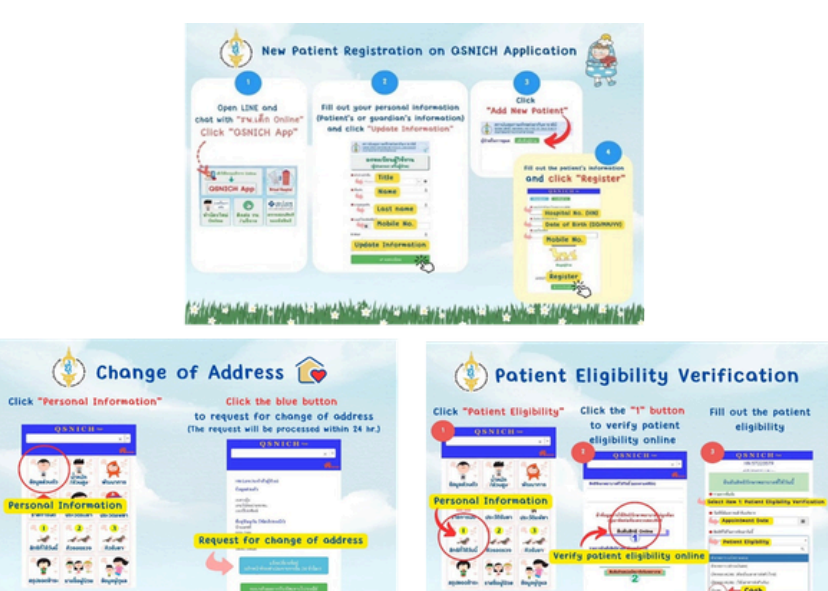
Lost contact (หลุดนัด)



ผลลัพธ์ วงล้อรอบที่ 4

ภาพขั้นตอนการลงทะเบียน QSNICH APP version 4

คู่มือแนวทางปฏิบัติการพบแพทย์ทางไกลสำหรับผู้ให้บริการ



ผลกระทบ (Impact)

- ลดความแออัดของ OPD
- เพิ่มการเข้าถึงการบริการสำหรับผู้ป่วยต่างจังหวัด
- ลดเวลาและค่าใช้จ่ายของครอบครัว
- ยกระดับสู่ Smart Hospital & Digital Transformation
- เป็นต้นแบบ (Best Practice) ที่สามารถขยายผลได้อย่างยั่งยืน



ผลลัพธ์ วงล้อรอบที่ 5

รอบที่ 5 ปัญหา :: ผู้ให้บริการ (ทีมแอดมินประจำศูนย์ Telemed) มีการหมุนเวียนร่วมกับสถาบันมีนโยบายแบ่งงานภายในสภาวะสงคราม (Tele ส่งยาไปรษณีย์)

คู่มือการปฏิบัติแอดมินศูนย์ประสานงาน

คำแนะนำการรับยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้รับบริการ

